

«Інфекційний ендокардит»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Зняти електрокардіограму.
- Описати ЕКГ.
- Оцінити ЕХОКС.
- Оцінити лабораторний тест- посів крові на стерильність
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

1. Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом інфекційний ендокардит».

Ви лікар терапевтичного відділення. До Вас звернулася жінка, 46 років, інженер.

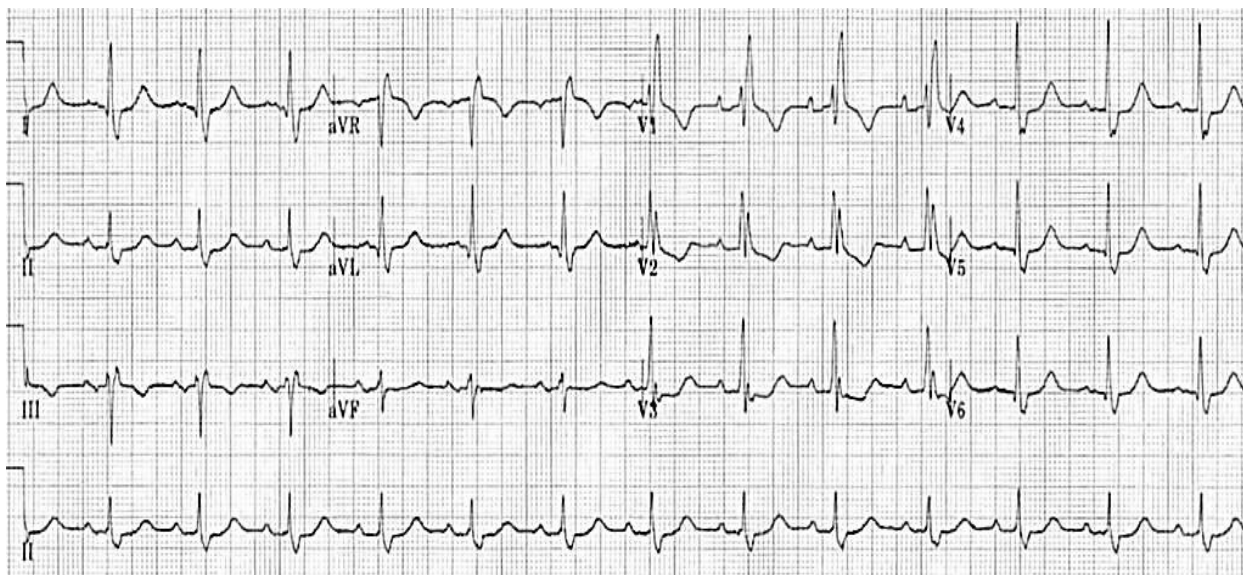
Скаржина інспіраторну задишку при незначних фізичних навантаженнях, набряки нижніх кінцівок, субфебрильну температуру, виражену загальну слабкість.

Анамнез захворювання: вважає себе хворою 1 місяць, коли після екстракції зуба, з'явилась температура $38,9^{\circ}\text{C}$, головний біль, слабкість. Лікувалась самостійно, приймала парацетамол. стан незначно покращився: знизилась температура тіла до $37,2^{\circ}\text{C}$, а через 3 тижні з'явилась задишка, набряки на ногах, narosla слабкість. Останній тиждень задишка посилилась, збільшились набряки, температура $37,5^{\circ}\text{C}$, виражена загальна слабкість.

Анамнез життя: страждає вродженою вадою серця - дефектом міжшлуночкової перегородки з дитячого віку

Об'єктивне обстеження: Стан середньої тяжкості. Шкірні покриви бліді з сіруватим відтінком. Периферійні набряки стоп і гомілок. В легенях:— везикулярне дихання, ЧДР – 26/хв. Серце: ліва межа – 5 м/р по лівій середньоключичній лінії, права – 2,5см назовні від правого краю грудини. Аускультативно - тони ритмічні, приглушені, грубий систолічний шум у 4 точці аускультатії, акцент 2 тону над легеневою артерією АТ на обох руках - 110/70 мм.рт.ст, ЧСС=Ps= 110 /хв. Живіт м'який, безболісний. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 2-3 см, селезінка + 2-3 см. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Додаток І ЕКГ



Додаток 2. Посів крові на стерильність

Посів крові на стерильність		
Матеріал, що досліджується	Результат пацієнта	Референтні значення
Венозна кров	Streptococcusviridans 10 ⁶	відсутній

Додаток 3 ЕХОКГ

ТРАНСТОРАКАЛЬНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЦЯ З КОЛЬОРОВОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЄЮ

Аорта:

Аорта (корінь) **3,5 см** (2,2-3,6см).

Стінки орти **норма**.

Ампл. розкр. Стулока орти **2,0 см** (1,5-2,2 см).

Стулки аортального клапану **норма**.

Стеноз Ао клапану **відсутній**.

Ліве передсердя:

Ліве передсердя (передньо-задній розмір) **3,4** (4 см).

Стулки мітрального клапану **норма**.

Розкриття мітрального клапану **2,3 см** (1,9 - 2,8см).

Лівий шлуночок:

Кінцево-діастолічний діаметр ЛШ (КДР) **4,8 см** (3,5- 5,6 см).

Кінцево-сistolічний діаметр ЛШ (КСР) **3,2 см** (2,3 -4,0 см).

Кінцево-діастолічний об'єм ЛШ (КДО) **107 мл** (70-160 мл).

Кінцево-сistolічний об'єм ЛШ (КСО) **40 мл** (20-70 мл).

Візуалізується дефект в перимембранозній частині міжшлуночкової перегородки (МШП) розміром до 1,0 см, краї дефекту ущільнені, при кольоровому доплерівському картуванні (КДК) реєструється ліво-правий скид шириною до 0,48 см.

Масаміокарду **92 г** (95 г (ж) 135 г (ч)).

Фракція викиду ЛШ (Teicholz) 49% (55-65%).

Фракція скорочення **32%** (28 - 43%).

Задня стінка діаст. **1,0 см** (0,6-1,1см).

Правий шлуночок та праве передсердя:

Правий шлуночок **3,8 см** (3,0 см).

Товщина стінки ПШ **0,8 см** (**0,5 см**).

Праве передсердя (медіально-латеральний розмір) **4,8 см** (2,0-3,8 см).

Стулки 3-стулков. клапану – регургітація 2 ст..

Стовбур легеневої артерії **3,2 см** (2,0-3,3 см), регургітація **2 ст.**

Над і під клапаном легеневої артерії візуалізуються рухомі вегетації довжиною до 10-13 мм, регургітація 2 ст

Сер тиск в ЛА (метод Кітабатаке/легенева регургітація) **47 мм. рт. ст.** (25 мм. рт. ст.)

Реакція нижньої порожистої вени на фази дихання нормальна.

Висновок: Візуалізується дефект в перимембранозній частині міжшлуночкової перегородки (МШП) розміром до 1,0 см, краї дефекту ущільнені, при кольоровому доплерівському картуванні (КДК) реєструється ліво-правий скид шириною до 0,48 см. Гіпертрофія міокарду правого шлуночка та інфундибулярного відділу ПШ з ознаками динамічної обструкції (градієнт 82 мм.рт.ст). Діастолічна дисфункція ПШ 1-й тип Трикуспідальна регургітація 2 ст. Помірна дилатація правого передсердя. Над і під клапаном легеневої артерії візуалізуються рухомі вегетації довжиною до 10-13 мм, функція клапана порушена, регургітація 2 ст. Фракція викиду (ФВ) - 49 %.

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції.

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження:

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>	Форма представлення
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
	інформовану згоду отримано;	Сказати
	обробити руки на гігієнічному рівні.	Виконати
2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «РЕЄСТРАЦІЯ ЕКГ У 12 СТАНДАРТНИХ ВІДВЕДЕННЯХ»:		
	Нанести гель або воду на місце постановки електродів	Виконати
	Коректне накладання 4 пластинчатих (стандартних) електродів: - червоний - права верхня кінцівка - жовтий - ліва верхня кінцівка - зелений - ліва нижня кінцівка	

	- чорний - права нижня кінцівка	
	Коректне накладання грудних електродів: 1-й – 4 м/р біля краю грудини справа; 2-й - 4 м/р біля краю грудини зліва; 4-й – 5 м/р по середньо-ключичній лінії зліва; 3-й – по середині між 2-м та 4-м електродами; 5-й – 5 м/ по передній пахвинній лінії; 6-й - 5 м/ по середній пахвинній лінії.	Виконати
	Реєстрація ЕКГ (натиснути «Пуск»)	
	Зняття стандартних і грудних електродів з пацієнта	
	Самопочуття пацієнта задовільне	Сказати
ДІАГНОСТИКА:		
<i>Описати ЕКГ</i> (Додаток 1)	Ритм синусовий. Правильний. ЧСС- 88 за хв. Електрична вісь -30°.Повна блокада правої ніжки пучка Гіса	Сказати/записати в історію хвороби
<i>Оцінити ЕХОКС</i> (Додаток 3)	Наявність рухомих вегетацій над і під клапаном легеневої артерії є великим критерієм інфекційного ендокардиту. дефект в перимембранозній частині міжшлуночкової перегородки (вроджена вада з анамнезу), який сприяє розвитку інфекційного ендокардиту є малим критерієм інфекційного ендокардиту.	Сказати/записати в історію хвороби
<i>Оцінити лабораторний тест- посів крові на стерильність:</i> (Додаток 3)	Позитивна гемокультура (типовий мікроорганізм (Streptococcusviridans), виділений із двох флаконів) є одним з великих критеріїв діагностики інфекційного ендокардиту	Сказати/записати в історію хвороби
<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Інфекційний ендокардит. Серцева недостатність.	Сказати/записати в історію хвороби

4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ		
<i>Призначено наступні ліки:</i>	Госпіталізація для подальшого обстеження та підбору оптимальної терапії. Група бета-лактамних пеніцилінів або цефалоспоринів III покоління – 4- 6 тижнів. β-блокатори Інгібітори АПФ/БРА II Петльові діуретики	Сказати/записати в історію хвороби
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:		
	показаний охоронний режим до 6 місяців, потрібно обмежити сіль і рідину, фізичні навантаження, перегрівання, переохолодження і перебування у вологих приміщеннях	Сказати/записати в історію хвороби